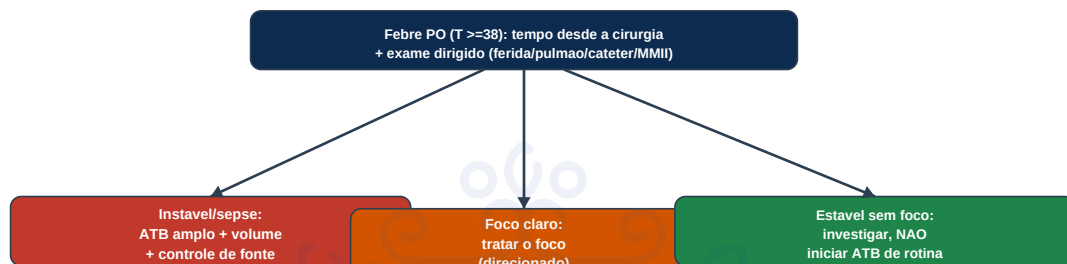


FEBRE PÓS-OP — TEMPO SUGERE A CAUSA

FLUXOGRAMA — ESTÁVEL x SÉPTICO

FEBRE PÓS-OP — TRIAGEM PELA ESTABILIDADE



CAUSAS POR JANELA TEMPORAL (OS 'Ws')

Tempo	Causas mais prováveis
Imediata (< 24h)	Resposta inflamatória ao trauma cirúrgico; reação transfusional; hipertermia maligna; medicamentos
Precoce (24-72h)	Atelectasia/pneumonia aspirativa; ISC superficial; flebite/cateter; reação a medicamento
Intermediária (3-7d)	ISC superficial/profunda; pneumonia nosocomial; ITU por sonda; TVP/tromboflebite; infecção de dreno
Tardia (> 7d)	Abscesso intra-abdominal/coleção; ferida profunda/deiscência; empiema; C. difficile (pós-ATB); fungos (imunossuprimido)

AVALIAÇÃO E EXAMES

FOCO DIRIGIDO

- Definição: T >= 38 °C (ou >= 1 °C acima do basal) no pós-operatório
- Exame: pulmões, ferida operatória (secreção/eritema/calor), cateteres, abdome, MMII (TVP); checar débito/aspecto dos drenos
- Exames: hemograma, PCR/procalcitonina, gaso/lactato se sepsis, função renal/eletrólitos, RX de tórax
- Hemoculturas x2 (antes do ATB se não atrasar) + cultura de sítio (ferida, dreno, urina de sonda)
- Imagem: US/TC de abdome se suspeita de coleção; ecodoppler de MMII se suspeita de TVP

CONDUTA E ANTIBIÓTICO EMPÍRICO

Rx QUANDO E O QUE INICIAR

INSTÁVEL/seps: ATB empírico amplo IMEDIATO + ressuscitação volêmica + controle de fonte (remover cateter suspeito, drenar coleção); hemoculturas antes se não atrasar

ESTÁVEL sem foco: investigar primeiro; NÃO iniciar ATB de rotina sem evidência de infecção bacteriana

FOCO claro: tratamento direcionado (ATB dirigido, drenagem, troca de cateter)

Seps abdominal: Piperacilina-tazobactam 4,5 g EV 6-8/8h (ou Ceftriaxona 2 g + Metronidazol; Meropenem se risco ESBL)

Pneumonia pós-op: Pipe-tazo ou Cefepime; + Vancomicina se risco de MRSA; cateter purulento: Vancomicina ±

Gram-negativo + remover cateter

Ajustar à função renal; descalonar por cultura em 48-72h; duração guiada pelo foco e controle de fonte

CAUSAS NÃO INFECCIOSAS / EMERGÊNCIAS

NÃO ESQUECER

- Atelectasia (febre baixa precoce): fisioterapia respiratória, mobilização, CPAP — não é indicação de ATB
- Reação transfusional: interromper a transfusão, suporte, notificar hemoterapia; vigiar hemólise
- HIPERTERMIA MALIGNA (durante/logo após anestesia): hipertermia + rigidez + acidose/hipercapnia -> DANTROLENE 2,5 mg/kg EV + resfriamento
- TEP: taquipneia, hipóxia, dor torácica -> angio-TC e anticoagulação conforme risco
- 'Febre' nem sempre é infecção — valorizar o contexto temporal; se instável, trate primeiro e investigue depois

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ POn de ____ (cirurgia); febre iniciada ____ (imediata/precoce/intermediária/tardia).
- Foco: ferida ____, pulmão ____, urina/sonda ____, cateter ____, MMII/TVP ____; sinais de seps ____.
- Exames: leucócitos ____, PCR ____, lactato ____, RX/TC ____; hemoculturas x2 ____.
- Conduas: ATB ____ às ____ (se indicado), controle de fonte ____; solicito UTI/cirurgia/radiologia intervencionista conforme foco.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente estável no 2º PO com febre baixa, opacidades basais no RX e melhora com fisioterapia respiratória. Causa mais provável?

- A) Abscesso intra-abdominal
- B) Atelectasia
- C) Infecção urinária
- D) Deiscência anastomótica
- E) Empiema pleural

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Diante de febre pós-operatória em paciente ESTÁVEL e SEM foco definido, qual a conduta?

- A) Iniciar antibiótico empírico de amplo espectro para todos
- B) Investigar (hemoculturas, RX, leuco/PCR) e NÃO iniciar ATB de rotina sem evidência de infecção
- C) Alta imediata
- D) Reabordagem cirúrgica
- E) Corticoide sistêmico

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Febre tardia (> 7 dias) após cirurgia abdominal, com dor e leucocitose. Qual a principal hipótese e o exame?

- A) Atelectasia; RX de tórax
- B) Abscesso/coleção intra-abdominal; TC de abdome e pelve com contraste
- C) Reação transfusional; coombs
- D) Hipertermia maligna; gasometria
- E) Flebite; ecodoppler

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Hipertermia maligna no intra/pós-anestésico imediato. Qual o tratamento específico?

- A) Paracetamol
- B) Dantrolene 2,5 mg/kg EV + resfriamento ativo e suporte
- C) Antibiótico de amplo espectro
- D) Corticoide
- E) Apenas observação

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual princípio é correto no manejo da febre pós-operatória com instabilidade/sepsis?

- A) Aguardar todas as culturas antes de qualquer medida
- B) Tratar primeiro (suporte + ATB empírico + controle de fonte) e investigar em paralelo
- C) Nunca remover cateteres
- D) Evitar hemoculturas
- E) Iniciar ATB oral ambulatorial

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Febre baixa precoce com opacidades basais que melhora com fisioterapia respiratória sugere atelectasia — não é indicação de antibiótico; trata-se com expansão pulmonar e mobilização.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

No paciente estável sem foco, investiga-se primeiro (hemoculturas, RX, leuco/PCR) e NÃO se inicia ATB de rotina sem evidência de infecção bacteriana.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Febre tardia (> 7d) após cirurgia abdominal, com dor e leucocitose, sugere abscesso/coleção intra-abdominal; a TC de abdome e pelve com contraste é o exame para localizar e guiar a drenagem.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hipertermia maligna é tratada com dantrolene 2,5 mg/kg EV (repetível), resfriamento ativo, correção metabólica e suporte intensivo.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na presença de instabilidade/seps, trata-se primeiro (suporte + ATB empírico + controle de fonte) e investiga-se em paralelo, colhendo hemoculturas sem atrasar a terapia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico